

耳鼻咽喉科講義

2025年2月

名古屋市立大学病院 耳鼻咽喉科
角谷尚悟

耳



鼻



のど



頸部



聴覚



嗅覚



味覚
嚙下



発声





聞こえない、声が出ない・・・意思疎通に支障

味や臭いがわからない・・・食事がまずい

平衡感覚が狂うと動けない





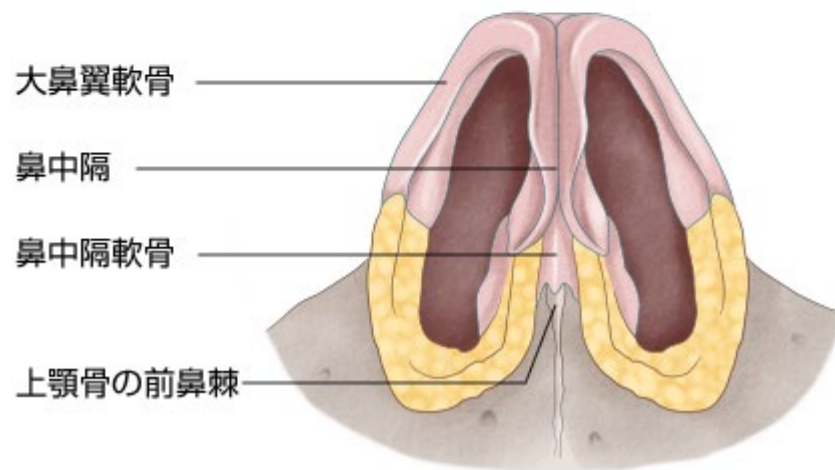
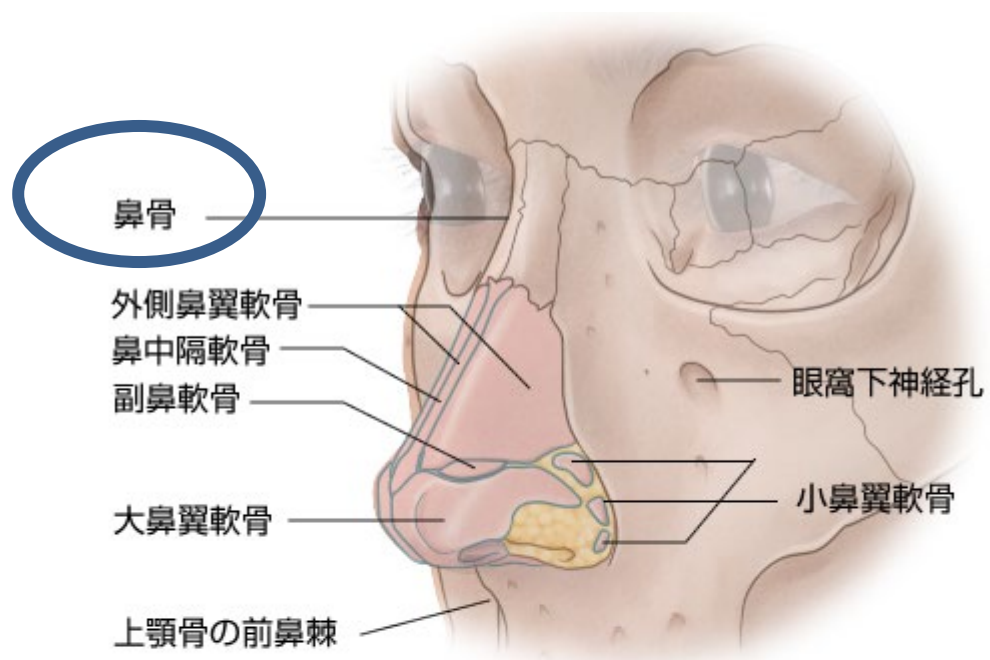
**解剖、生理を理解し、
疾患の特徴をおさえましょう**

ここだけは覚えましょう

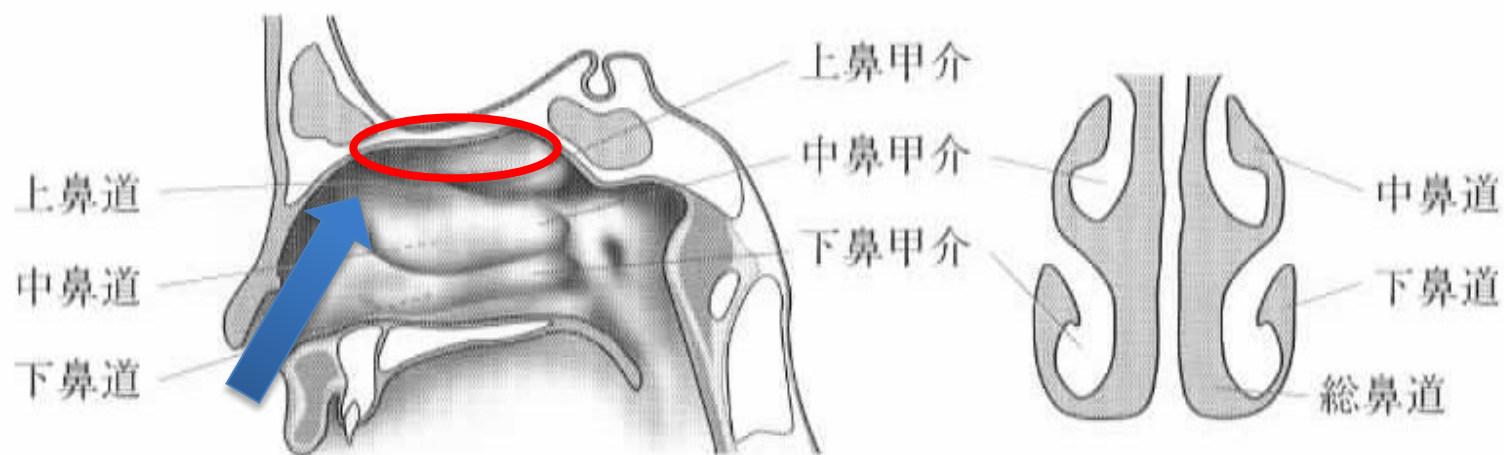
- 解剖 鼻骨、眼窩、副鼻腔、嗅裂
- アレルギー性鼻炎
 - 1型アレルギー、季節性と通年性
 - 治療法 抗ヒスタミンと点鼻ステロイド
 - 舌下免疫
- 鼻出血 危険因子と正しい対処
- 副鼻腔炎
 - 原因と治療(内科的治療と外科的治療)



鼻の解剖と生理



鼻腔

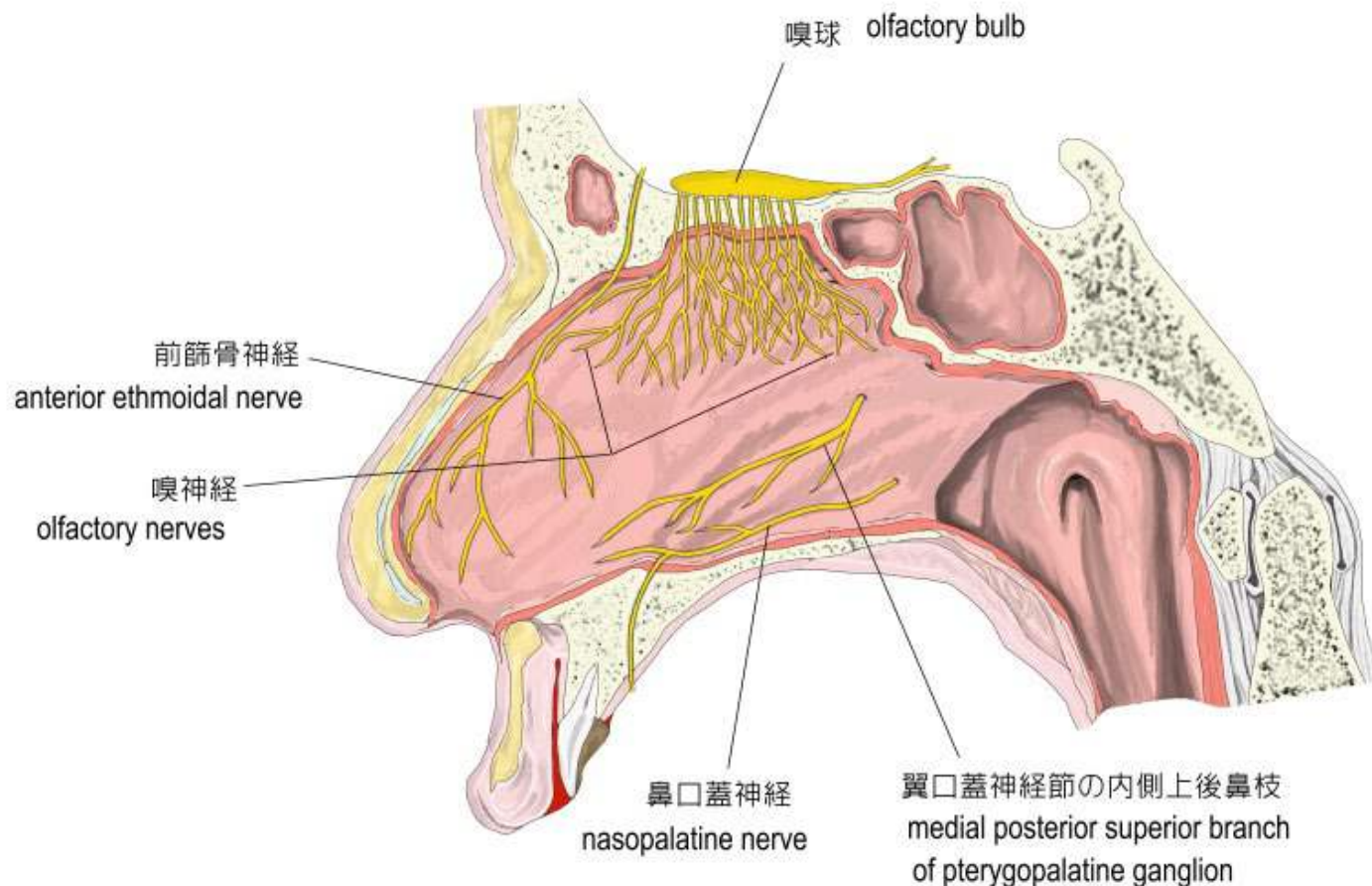


嗅部： 嗅球→嗅神経

鼻粘膜には繊毛が存在



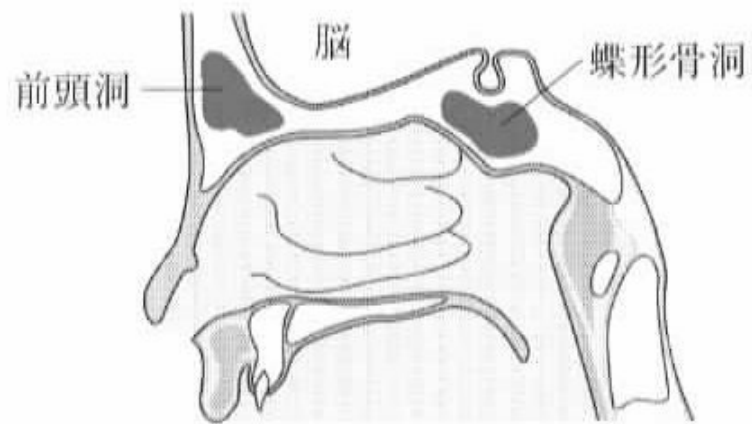
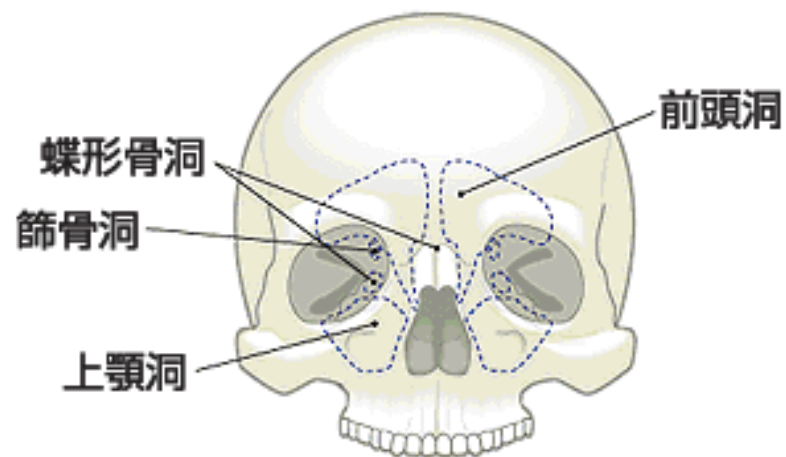
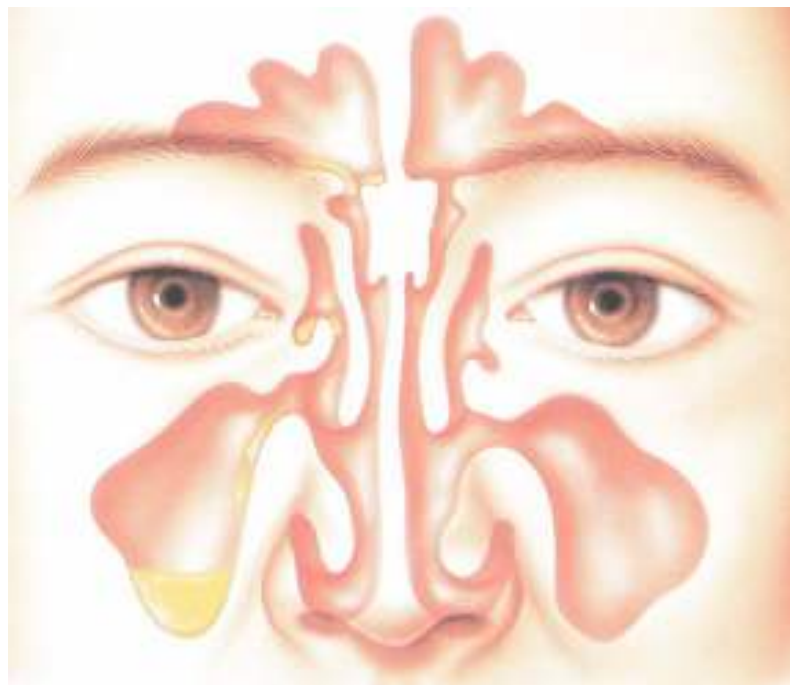
嗅神経は脳神経より核を分岐せず 直接嗅球に至る



嗅覚障害

- 呼吸性嗅覚障害 **副鼻腔炎**
におい成分が鼻腔内で物理的にさえぎられる
- 嗅粘膜性嗅覚障害
嗅細胞の存在する粘膜が障害
- 嗅神経性嗅覚障害 **感冒・COVID-19など**
ウイルス感染や薬剤による
- 中枢性嗅覚障害 **頭部外傷**
中枢神経の障害による

副鼻腔



鼻の機能

嗅覚

加湿

加温

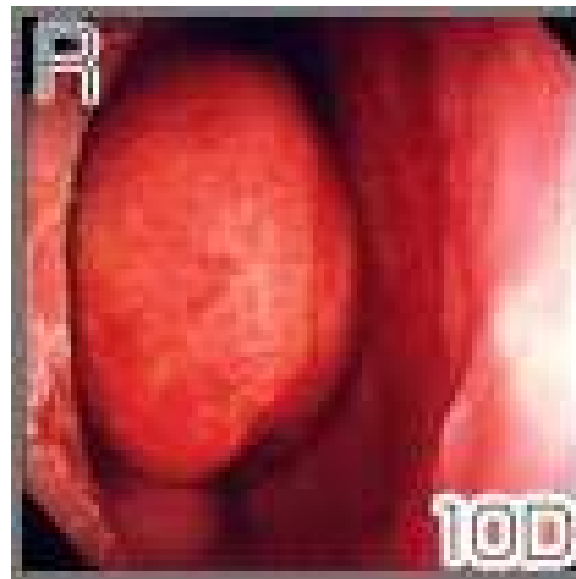
除塵

共鳴腔

共鳴障害

1. 閉鼻声（閉塞性鼻声）・・・鼻閉が高度
2. 開鼻声（開放性鼻声） “鼻にかかった声”
軟口蓋麻痺・穿孔、口蓋裂
（鼻咽腔と口腔との間が閉じられないと）

ファイバースコープ



嗅覚検査



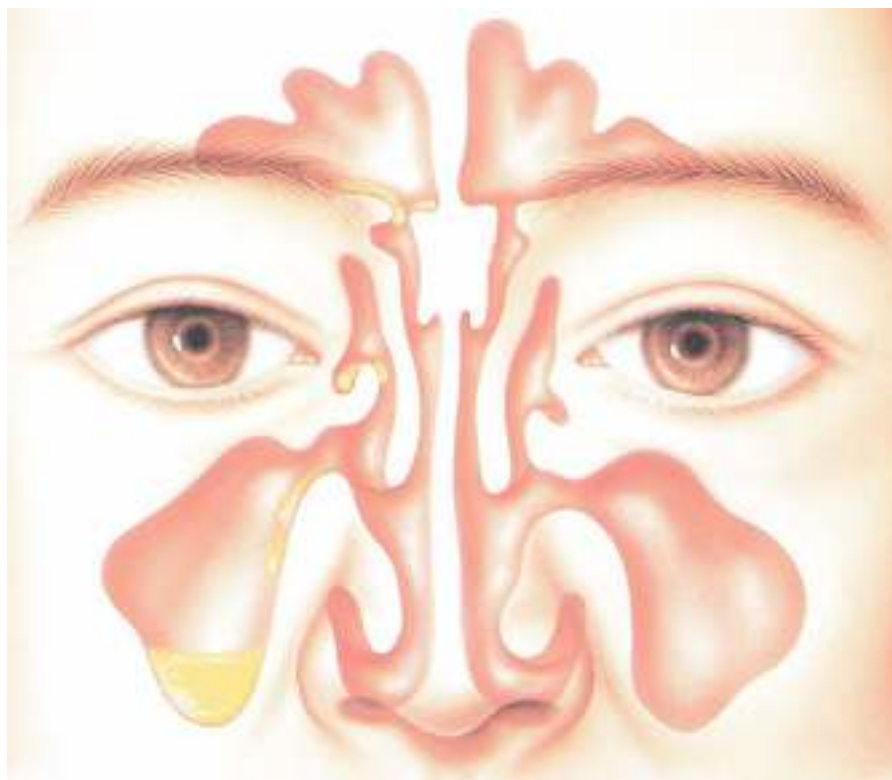
電気味覚検査



濾紙ディスク味覚検査



鼻の疾患

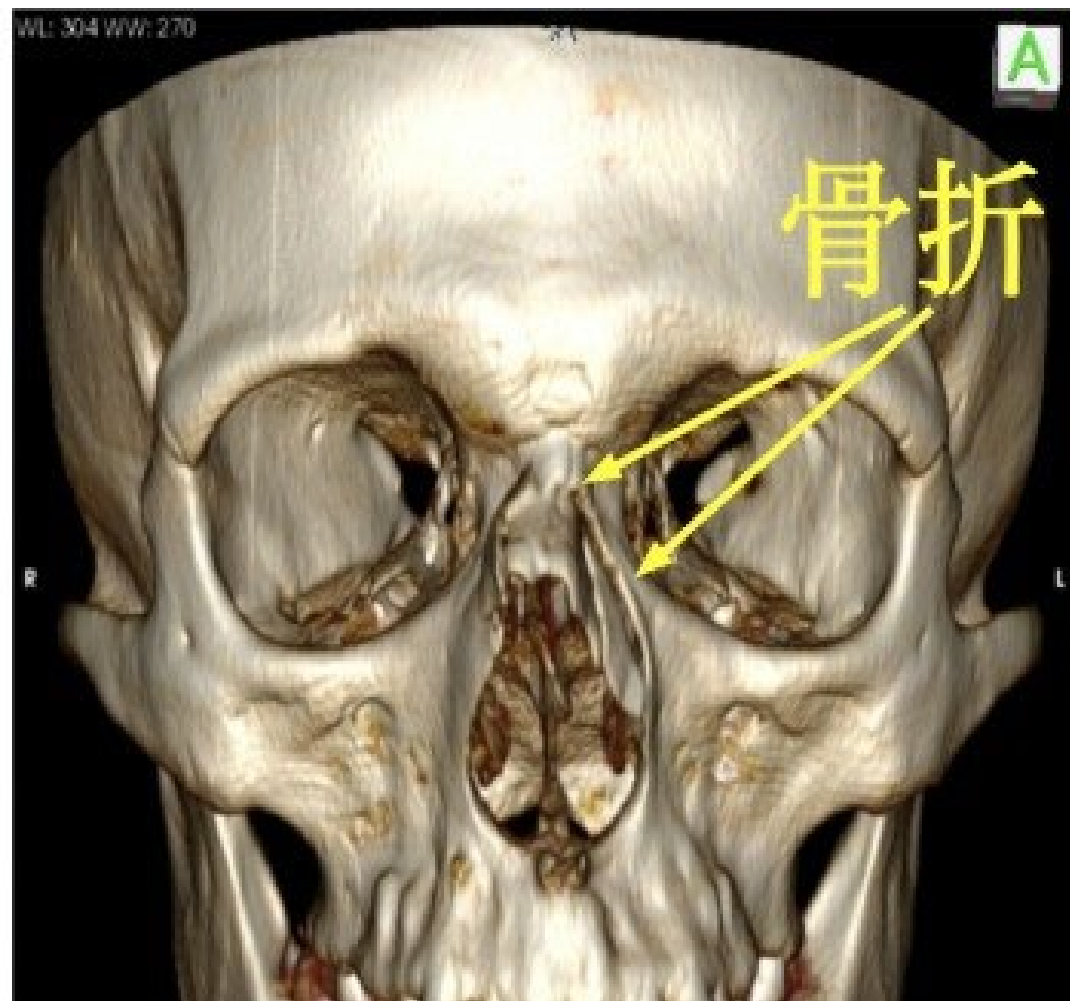


外鼻疾患

外傷

① 鼻骨骨折

• 整復

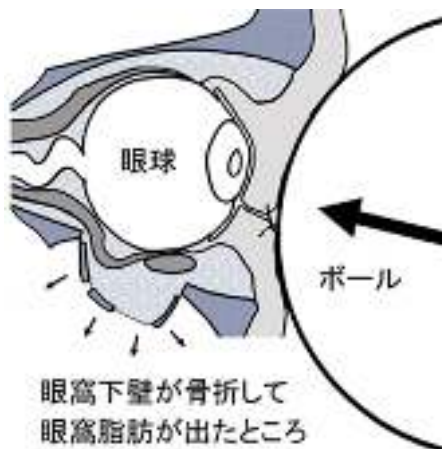


鼻骨骨折整復



②眼窩壁骨折

眼部前方からの鈍的な外力で容易に起こる
複視、眼球運動痛などが生じることがある



治療

症状あれば手術で整復することが多い

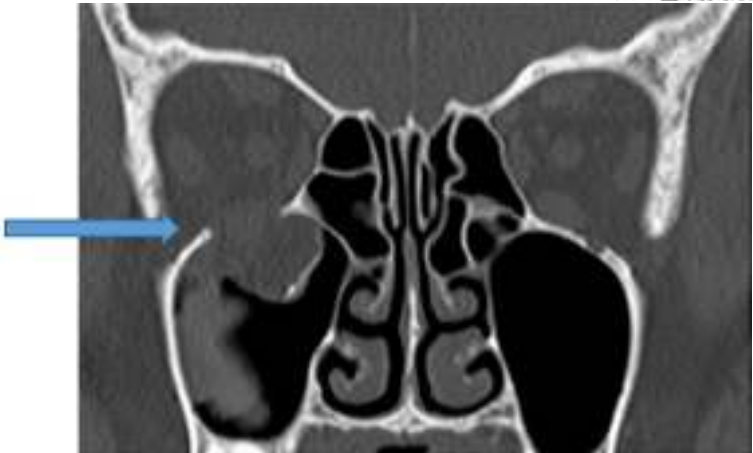


井上尚弥 眼窩底などを骨折 11/9(土) 20:51

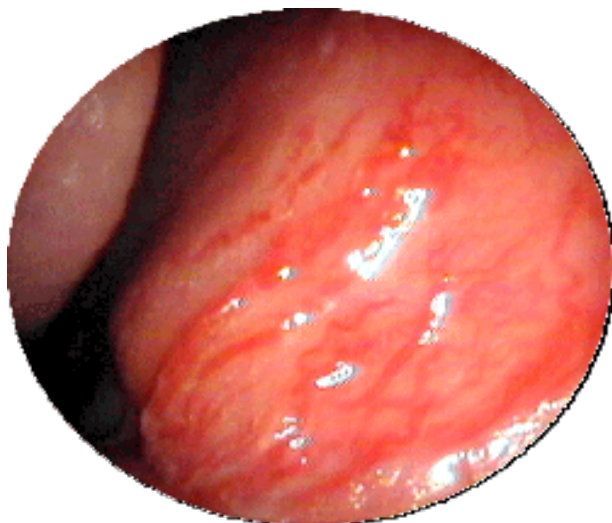
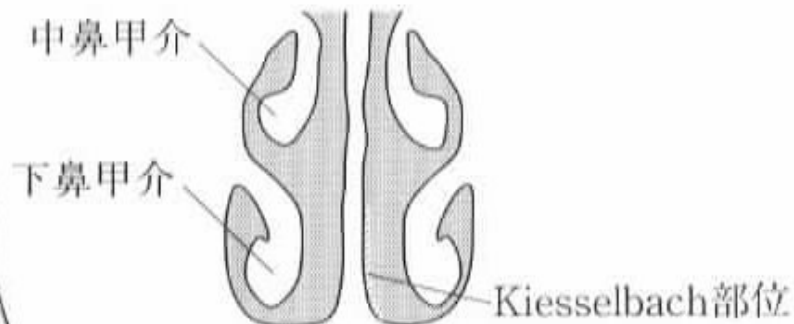
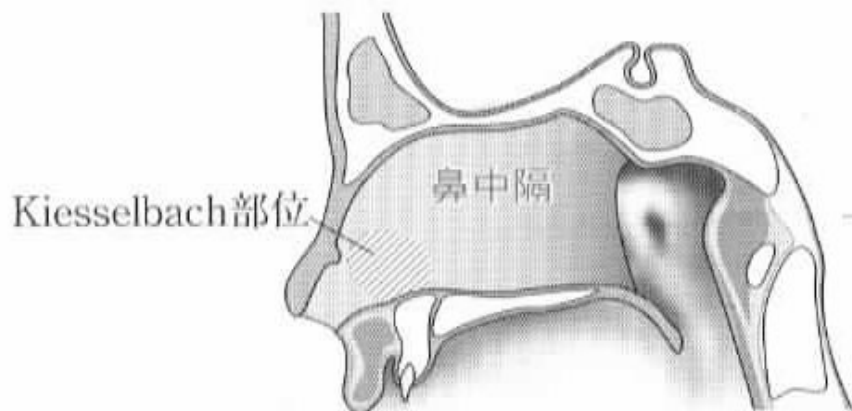
📷 日刊スポーツ

井上尚弥が眼窩底など2カ所骨折 再検査で次戦判断

日刊スポーツ ■ 103



③鼻出血



全身的原因

- 1) 高血压
- 2) 血液疾患・肝疾患
(易出血性疾患)
- 3) 抗凝固剂



治療

- 1) **K i e s s e l b a c h**の圧迫止血
粘膜麻酔薬
血管収縮薬ガーゼ
- 2) 薬剤 もしくは **電気焼灼**
- 3) **ベロックタンポン**による止血





鼻腔疾患

- 鼻中隔彎曲症
- 鼻出血
- 急性鼻炎 鼻風邪
- 慢性単純性鼻炎
- 肥厚性鼻炎 下鼻甲介の腫脹 下鼻甲介切除術
- アレルギー性鼻炎
- 血管運動性鼻炎
- ウェゲナー肉芽腫症 上気道、肺、腎など
鼻閉、膿性・血性鼻漏、鼻中隔軟骨破壊、
鞍鼻

鼻中隔彎曲症

- 鼻中隔の彎曲が強く、鼻閉を生ずる
- 鼻中隔矯正術



鼻中隔矯正術



アレルギー性鼻炎

I 型アレルギー

抗原が不明→血管運動性鼻炎

抗原が花粉→花粉症

スギ、ヒノキ 春

雑草、イネ 夏-秋

通年性 ハウスダスト、カビ

症状 くしゃみ、水溶性鼻漏、鼻閉

所見 鼻粘膜が蒼白、腫脹



左鼻



ID NO.
NAME
SEX AGE
D.O.BIRTH
2012/04/24
18:02:08



COMMENT

アレルギー性鼻炎

治療 薬剤

点鼻ステロイド

抗アレルギー剤

減感作療法（舌下免疫等）

手術

レーザー焼灼手術

粘膜下鼻甲骨切除術

後鼻神経切断術

鼻粘膜焼却術

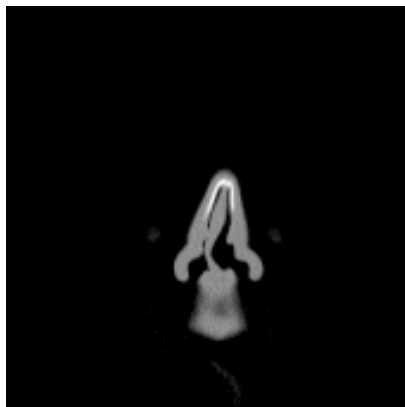


症例 20M 外傷性斜鼻、鼻閉

主 訴：いびき

病 歴：以前からのいびきで前医受診、CTで鼻
中隔前端からの弯曲と軽度の斜鼻あり、外鼻形
成術適応と考え当科紹介

既往歴：なし



Open septoplasty



手術時間3 : 05、出血量55cc

術前後の比較

術前

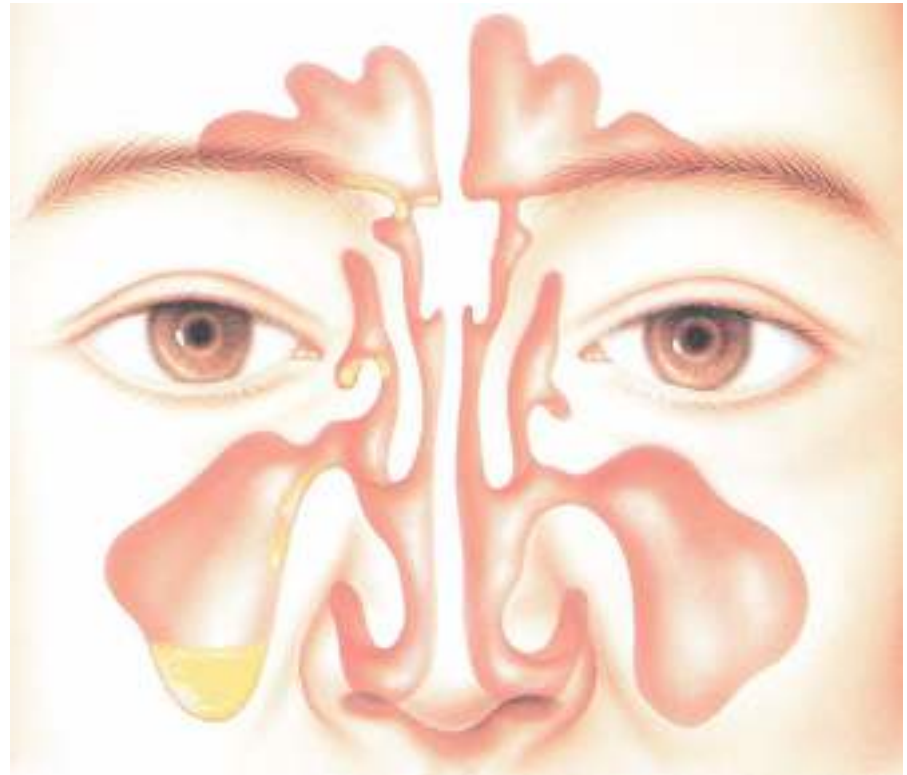


術後



副鼻腔疾患

- 急性副鼻腔炎
- 慢性副鼻腔炎
- 術後性上顎嚢胞



急性副鼻腔炎

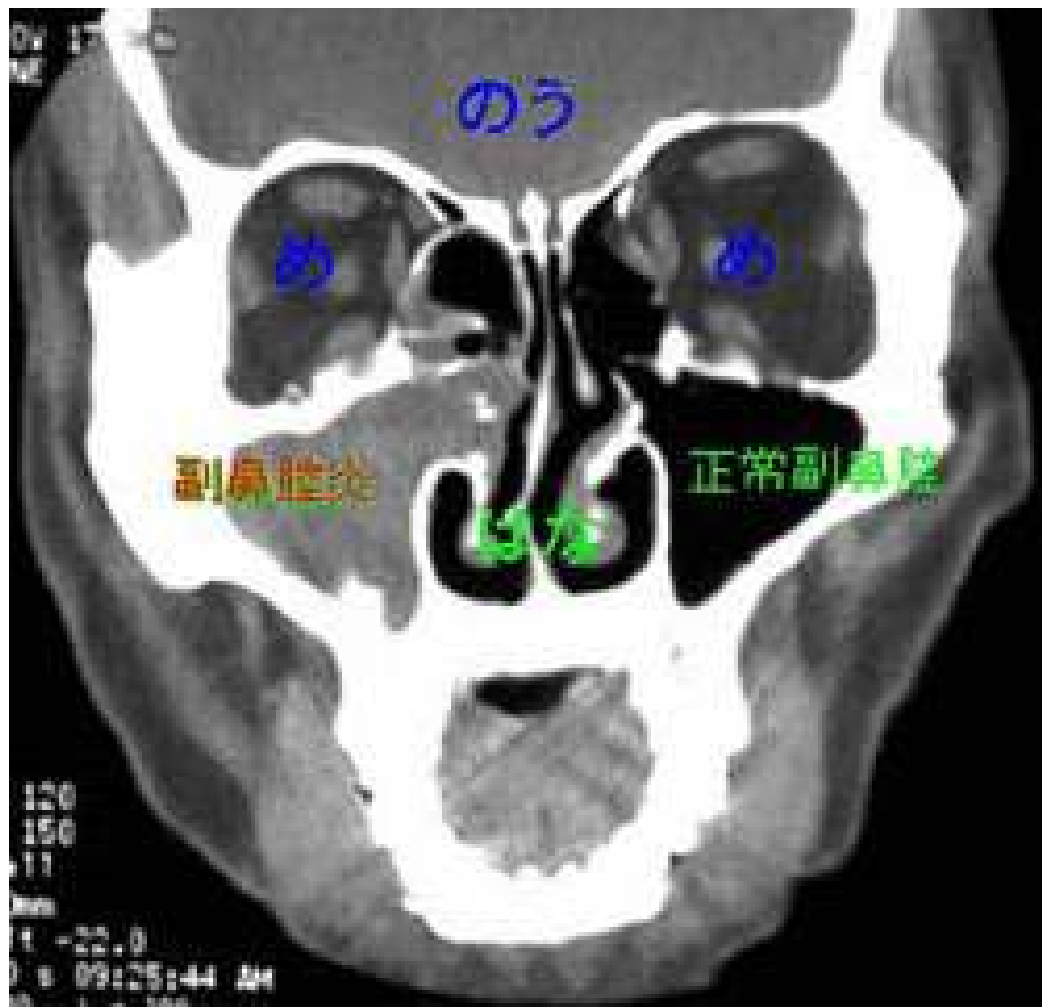
- 急性上気道炎にひき続き波及することが多い
- 上顎洞，篩骨洞が多い
- 歯性上顎洞炎
- 水泳・潜水から（気圧の変化） ・ ・ 飛行機も

急性副鼻腔炎

症状

- 鼻漏、後鼻漏
- 頬部痛，歯痛
- 嗅覚障害
- 頭痛
- 発熱
- 全身倦怠感

CT



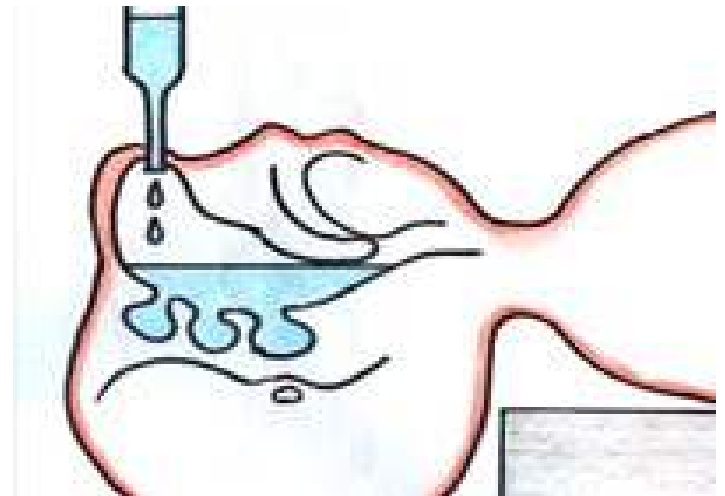
急性副鼻腔炎

起因菌

- 肺炎球菌
- インフルエンザ菌
- 黄色ブドウ球菌
- モラキセラ・カタラーリス

治療

- 内服治療 **抗生剤** **消炎剤**
- 局所療法 **血管収縮剤**
- **プレッツ置換法**
- 外科的治療



慢性副鼻腔炎 (蓄膿症)

両側かつ多洞にわたることが多い。

症状

- 鼻閉
- 鼻漏
- 嗅覚障害
- 頭痛，頭重感
- 時に注意不能，易疲労感

難治性副鼻腔炎 →好酸球性副鼻腔炎

鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎 患者さんの声

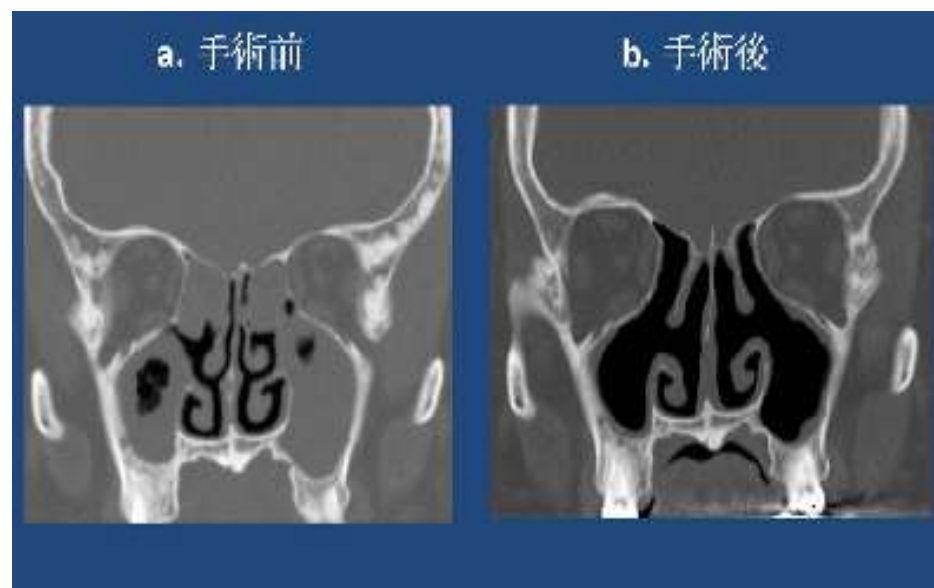
チョコレートプラネット (お笑い芸人)



慢性副鼻腔炎

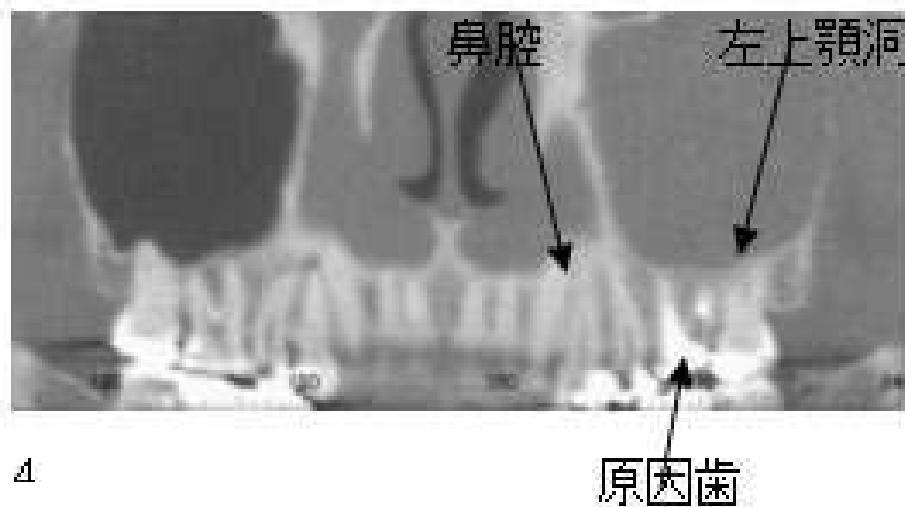
治療

- 保存的治療
少量長期マクロライド投与
- 手術療法
内視鏡下鼻副鼻腔手術



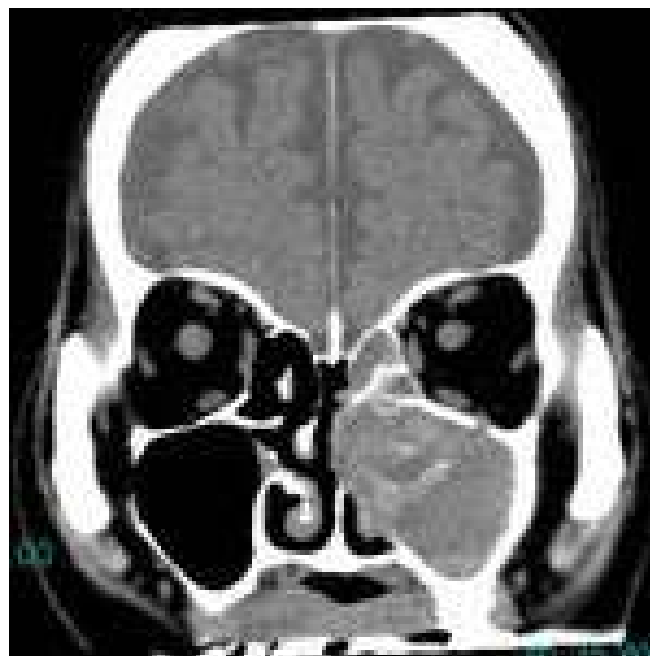
慢性副鼻腔炎

歯性上顎洞炎



歯が原因
歯の治療も併
行

副鼻腔真菌症



真菌（カビ）が原因
内服はほぼ無効→手術

症例 40F ECRS (JESRECスコアー15点)

主訴：鼻閉、嗅覚障害

病歴：アレルギー性鼻炎で前医で加療中。

鼻閉と嗅覚障害が出現して当科へ手術目的で紹介。

既往歴：

下鼻甲介レーザー手術

気管支喘息

末梢血好酸球 6%



右



左

好酸球性副鼻腔炎の診断

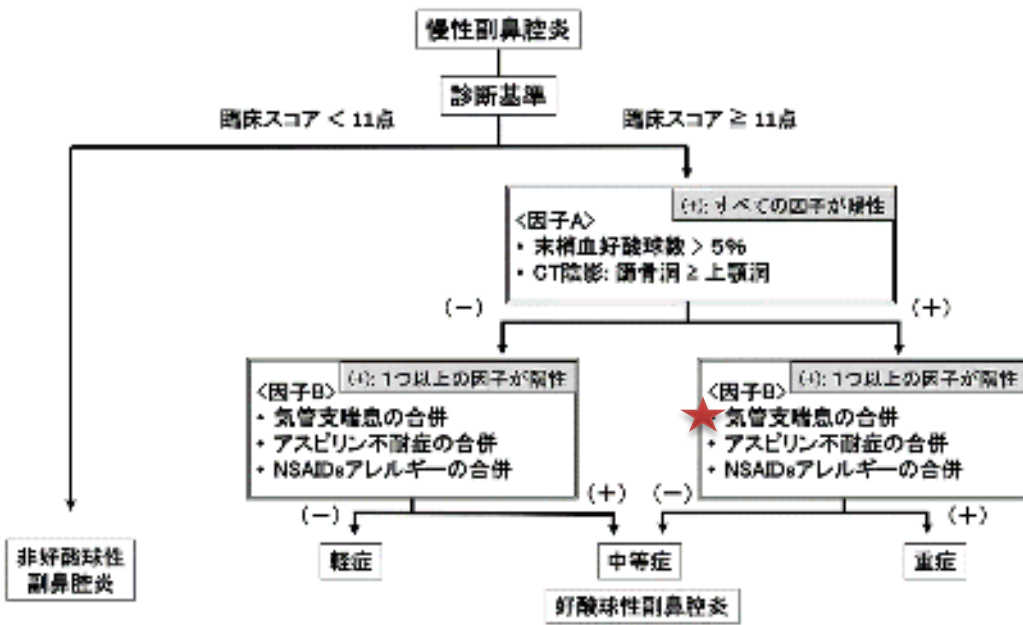
藤枝ら. 日耳鼻 118: 728-735, 2015

好酸球性副鼻腔炎診断基準項目
(JESREC Study) 4)15)16)17)

項目	スコア
病側：両側	3点
鼻茸あり	2点
篩骨洞陰影／上顎洞陰影 ≥ 1	2点
血中好酸球 (%)	
2 < ≤ 5 %	4点
5 < ≤ 10 %	8点
10 % <	10点

スコアの合計：11点以上を好酸球性副鼻腔炎とする。
確定診断は、組織中好酸球数：70個以上

重症度分類



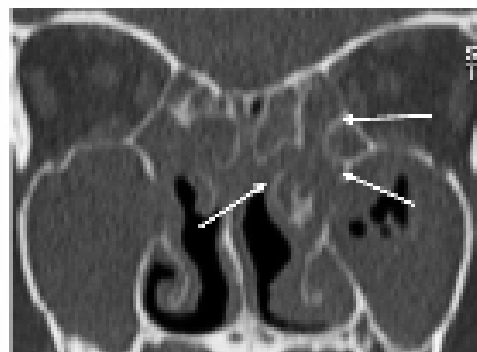
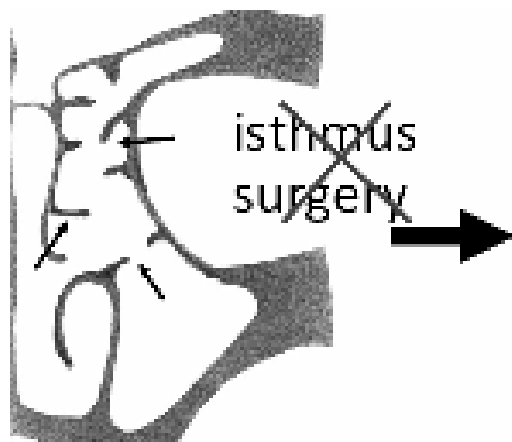
好酸球性副鼻腔炎の治療

- 薬物治療
 - 1) ステロイド点鼻薬＋抗ロイコトリエン薬
 - 2) 経口ステロイド薬（増悪時や術前後の限られた期間）
- 手術
 - 内視鏡下鼻副鼻腔手術（術前後にも薬物治療は必要）

難治性副鼻腔炎へのESSのコンセプト

慢性炎症改善のために
通気性をよくする鼻副鼻腔形態改善手術
→ 『単洞化手術』

好酸球性副鼻腔炎（アスピリン喘息、喘息合併例）で不完全だと・・・



的確な初回手術が重要



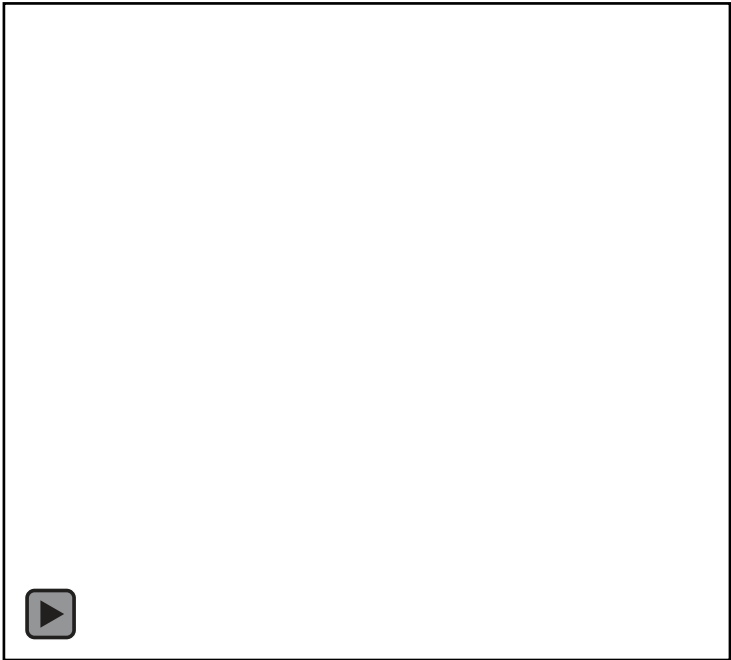
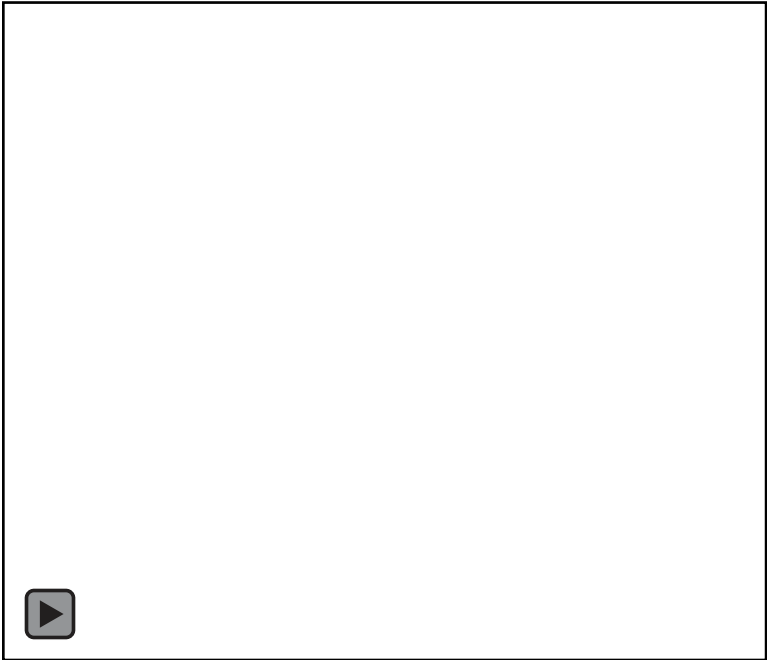
（春名眞一：耳鼻臨床2012）

両内視鏡下鼻・副鼻腔手術IV型 鼻中隔矯正術、粘膜下下鼻甲介骨切除

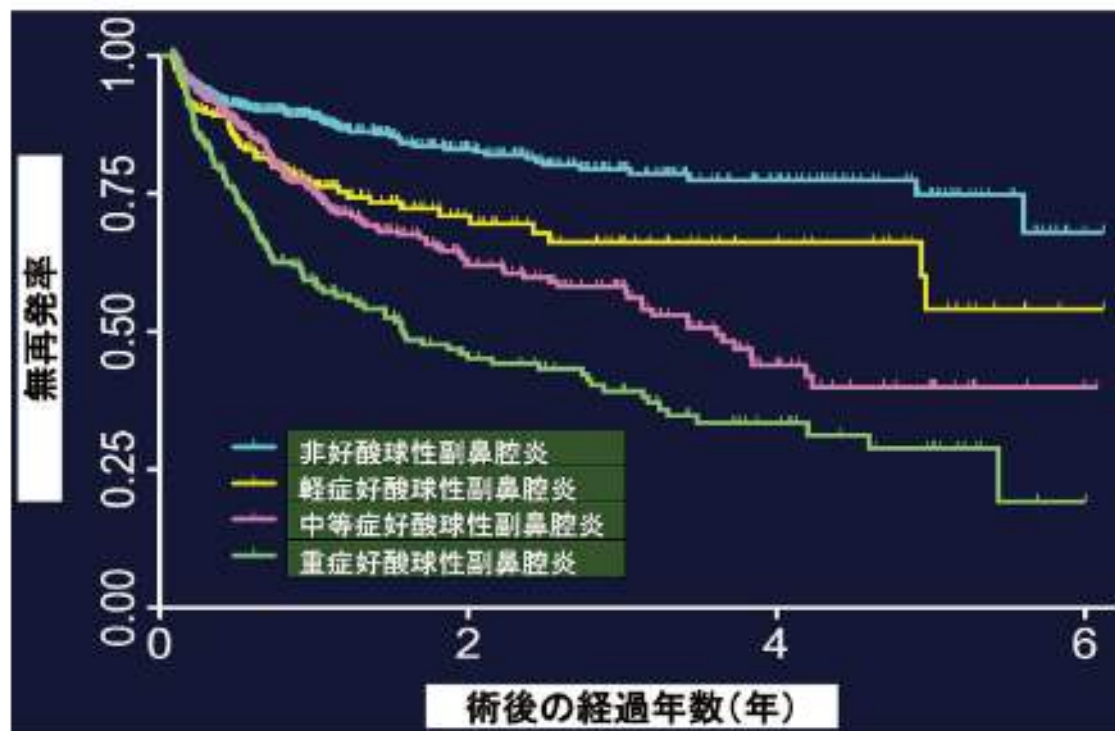


手術時間2：30、出血量85cc

術後 8 ヶ 月 時



重症度分類による無再発率



再発率

非好酸球性副鼻腔炎: 12.7%

好酸球性副鼻腔炎

軽 症: 23.4%

中等症: 31.1%

重 症: 51.8%

難治率

非好酸球性副鼻腔炎: 3.3%

好酸球性副鼻腔炎

軽 症: 11.7%

中等症: 16.6%

重 症: 29.4%

藤枝ら. 日耳鼻 118: 728-735, 2015

好酸球性副鼻腔炎の治療

気管支喘息の加療

- 薬物治療
 - 1) ステロイド点鼻薬＋抗ロイコトリエン薬
 - 2) 経口ステロイド薬（増悪時や術前後の限られた期間）
- 手術 内視鏡下鼻副鼻腔手術（術前後にも薬物治療は必要）



手術再発症例（難治例）

- 生物学的製剤 デュピルマブ （デュピクセント®）

ここだけは覚えましょう

- 解剖 鼻骨、眼窩、副鼻腔、嗅裂
- アレルギー性鼻炎
 - 1型アレルギー、季節性と通年性
 - 治療法 抗ヒスタミンと点鼻ステロイド
 - 舌下免疫
- 鼻出血 危険因子と正しい対処
- 副鼻腔炎
 - 原因と治療(内科的治療と外科的治療)